

1. У пацієнта виявлено протрузію зубів у фронтальному відділі верхньої щелепи. До якої групи аномалій прикусу належить ця патологія?

- A. Трансверзальних
- B. Транспозиційних
- C. Вертикальних
- D. Супраоклюзійних
- E. Сагітальних

2. Батьки восьмирічної дівчинки скаржаться на болісність та кровоточивість ясен у дитини. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен верхньої та нижньої щелеп у ділянці фронтальних зубів і перших постійних молярів набрякла, гіперемована, ясенні сосочки мають заокруглену форму. Тимчасові зуби відсутні. Також спостерігається симетричне ураження долоней і підшв у вигляді ділянок гіперкератозу коричневого кольору, що межують із зонами підвищеного злущування епідермісу. Для якого захворювання характерні ці клінічні симптоми?

- A. Синдром Папійона-Лефевра
- B. Пародонтальний синдром при цукровому діабеті
- C. Хвороба Таратина
- D. Хвороба Німанна-Піка
- E. Хвороба Гоше

3. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на погіршення загального стану, підвищення температури тіла до $38,0^{\circ}\text{C}$ у дитини, відмову від вживання їжі. Об'єктивно спостерігається: явища катарального гінгівіту, на тлі гіперемії слизової оболонки порожнини рота поодинокі дрібні пухирці та ерозії овальної форми з вінчиком гіперемії, різко болючі від дотику. Який імовірний діагноз?

- A. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
- B. Стоматит при корі
- C. Стоматит при краснуші
- D. Гострий герпетичний стоматит
- E. Стоматит при вітряній віспі

4. У пацієнта під час діагностичної пункції збільшених лімфатичних вузлів верхньої третини ший та піднижньощелепної ділянки зліва у пунктаті виявлено клітини Березовського-Штернберга. Яке захворювання можна діагностувати у цьому разі?

- A. Хронічний лімфолейкоз
- B. Лімфогранулематоз
- C. Інфекційний мононуклеоз
- D. Сифілітичний лімфаденіт
- E. Туберкульоз шийних лімфатичних вузлів

5. Під час огляду лікарем-стоматологом чоловік віком 54 роки поскаржився на загальну слабкість, головний біль, нудоту та біль у животі, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: пацієнт млявий, обличчя бліде без ознак ціанозу, губи, язик, шкіра сухі. Дихання рідке, глибоке, типу Куссмауля. У повітрі, що видихається, відчутний різкий запах ацетону. Тонус м'язів знижений, очні яблука м'які, АТ - 90/50 мм рт. ст. Який патологічний стан імовірно розвивається у пацієнта?

- A. Анафілактичний шок
- B. Колапс
- C. Епілептичний напад
- D. Гіпоглікемічна кома
- E. Гіперглікемічна кома

6. Жінка віком 25 років, якій три доби тому видалено 36 зуб, скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до $38,1^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка бліда, обличчя асиметричне через припухлість м'яких тканин у ділянці нижньої щелепи зліва, парестезія нижньої губи зліва, відкривання рота утруднене, альвеолярний відросток у ділянці 36 зуба муфтоподібно потовщений, слизова оболонка набрякла, гіперемована. З лунки 36 зуба виділяється гній. Який імовірний діагноз?

- A. Гострий остеомієліт нижньої щелепи
- B. Нагноєння радикулярної кістки нижньої щелепи
- C. Гострий гнійний лімфаденіт
- D. Флегмона підщелепної ділянки
- E. Гострий періостит нижньої щелепи

7. Пацієнтці віком 46 років проводиться лікування хронічного фіброзного пульпіту 47 зуба. Механічна обробка кореневих каналів була завершена 35 розміром ендодонтичного інструмента. Який колір по стандарту ISO відповідає інструменту 35 розміру?

- A. Білий
- B. Фіолетовий
- C. Чорний
- D. Червоний

Е. Зелений

8. Пацієнт віком 56 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах із рота та рухомість зубів, що турбують протягом 5-ти років. Після проведених клінічних та додаткових методів дослідження лікар встановив діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня, і запропонував план лікування. Яка основна мета лікування пародонтиту?

- А. Видалення зубної бляшки
- В. Досягнення стабілізації процесу
- С. Стимулювання регенерації
- Д. Усунення оклюзійної травми
- Е. Усунення запалення ясен

9. До лікаря-стоматолога звернулися батьки шестирічної дівчинки зі скаргами на припухлість підщелепної ділянки зліва у дитини. З анамнезу відомо, що дитина хворіє на гемофілію. Об'єктивно спостерігається: 74 зуб зруйнований на 2/3, реакція на термічні подразники негативна, перкусія слабоболісна, слизова оболонка перехідної складки у ділянці 74 зуба гіперемована, згладжена, болісна під час пальпації. На рентгенограмі виявлено нерівномірну резорбцію коренів 74 зуба, деструкція міжкореневої перетинки та кортикальної пластинки над фолікулом 34 зуба. Укажіть тактику лікаря у цьому разі.

- А. Періостотомія, видалення 74 зуба
- В. Видалення 74 зуба в умовах стаціонару
- С. Ендодонтичне лікування 74 зуба
- Д. Динамічне спостереження
- Е. Видалення 74 зуба

10. Чоловік віком 52 роки звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда зі скаргами на часте випадіння пломби в зубі на верхній щелепі справа. Об'єктивно спостерігається: 15 зуб зруйнований, кукса зуба виступає на 2 мм над яснами. На рентгенограмі кореневий канал запломбовано до рівня фізіологічної верхівки, периапікальних змін не виявлено. Пацієнту запропоновано виготовлення литої куксово-кореневої вкладки та металокерамічної коронки. Що допоможе попередити перелом кореня опорного зуба?

- А. Наявність ферул-ефекту в зубі
- В. Анатомічна форма коронки
- С. Фіксація куксової вкладки
- Д. Пломбування кореневого каналу
- Е. Зменшення навантаження

11. Батьки дворічної дитини звернулися до лікаря-стоматолога з приводу гострої травми зубів. Об'єктивно спостерігається: різучі краї центральних різців верхньої щелепи знаходяться на рівні маргінального краю ясен. Слизова оболонка альвеолярного відростка в ділянці ураження гіперемована, болісна під час пальпації. У ділянці уражених зубів незначна кровоточивість. Який попередній діагноз?

- А. Повний вивих 51 та 61 зубів
- В. Екструзивний вивих 51 та 61 зубів
- С. Інтрузивний вивих 51 та 61 зубів
- Д. Струс 51 та 61 зубів
- Е. Підвивих 51 та 61 зубів

12. Пацієнт віком 19 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на ниючий біль у ділянці нижньої щелепи праворуч після потрапляння їжі між зубами. З анамнезу відомо: два тижні тому було проведено лікування зубів саме в цій ділянці. Об'єктивно спостерігається: на контактних поверхнях 45 та 46 зубів композитні пломби, що не мають контакту між собою. Реакція на холод відсутня, вертикальна перкусія зубів безболісна, горизонтальна - слабо болісна. Ясенний сосочок між 45 та 46 зубами помірно набряклий, гіперемований, кровоточить від дотику. Зубо-ясенне прикріплення не порушене. Ясна прилеглих ділянок без патологічних змін. Установіть імовірний діагноз.

- А. -
- В. Папіліт
- С. Локалізований пародонтит
- Д. Локалізований гінгівіт
- Е. Ювенільний пародонтит

13. Жінка віком 25 років звернулася до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду ротової порожнини. Термін вагітності 23 тижні. Під час огляду на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 14 і 15 зуба виявлено білі, матові плями, гладенькі під час зондування. Вітальне фарбування позитивне. Яке лікування доцільно застосувати у цьому разі?

- А. Професійну гігієну
- В. Призначення зубної пасти з кальцієм
- С. Препарування і пломбування
- Д. Призначення полівітамінних засобів
- Е. Систему Icon

14. Чотирнадцятирічна дівчинка скаржиться на відчуття стягування губ, які вона постійно облизує. Об'єктивно спостерігається: червона облямівка губ суха, набрякла та гіперемована, вкрита лусочками, що легко знімаються, оголюючи неушкоджену яскраво-червону поверхню. Визначте ймовірний вид хейліту.

- A. Гландулярний
- B. Атопічний
- C. Ексфоліативний
- D. Метеорологічний
- E. Екзематозний

15. Пацієнт віком 47 років лікує прояви нейросифілісу. Укажіть причину виникнення синьо-чорної кайми по ясенному краю та появу плям такого ж кольору на слизовій оболонці щік, язика, губ.

- A. Інтوكсикація солями ртуті
- B. Фузоспірілярний симбіоз
- C. Бліда трепонема
- D. Інтоксикація солями свинцю
- E. Інтоксикація солями вісмуту

16. Який із нижченаведених антибіотиків не порушує процес формування зубної тканини і не призводить до виникнення гіоплазії зубів під назвою 'тетрациклінові зуби'?

- A. Ампіциліну тригідрат
- B. Метацикліну гідрохлорид
- C. Тайгециклін
- D. Міноцикліну гідрохлорид
- E. Доксицикліну гідрохлорид

17. У чотирирічної дівчинки під час огляду лікарем-стоматологом виявлено глибоку каріозну порожнину у 54 зубі, виповнену розм'якшеним дентином. Зондування дна каріозної порожнини безболісне. Реакція на термічні подразники та перкусію відсутня. На слизовій оболонці ясен у ділянці проєкції верхівок коренів 54 зуба виявлено слід від нориці. Установіть попередній діагноз.

- A. Хронічний глибокий карієс
- B. Хронічний гангренозний пульпіт
- C. Хронічний фіброзний періодонтит
- D. Хронічний фіброзний пульпіт
- E. Хронічний гранулюючий періодонтит

18. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на біль, що іррадіює у скроню та вухо у ділянці видаленого 3 дні тому 36 зуба,

неприємний запах з порожнини рота. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка у ділянці видаленого 36 зуба гіперемована, набрякла, лунка виповнена залишками згустку сірого кольору, підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Встановіть імовірний діагноз.

- A. Одонтогенний періостит нижньої щелепи від 46 зуба
- B. Одонтогенний лімфаденіт правої підщелепної ділянки
- C. Одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 зуба
- D. Невралгія III гілки трійчастого нерва
- E. Альвеоліт лунки видаленого 36 зуба

19. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на утруднене вживання їжі через травмування слизової оболонки альвеолярного відростка нижньої щелепи під час користування бюгельним протезом. Протез виготовлений тиждень тому. Після зняття протеза на рівні перехідної складки у ділянці відсутніх 45, 46 зубів із язикового боку виявлено болючу виразку розміром 1,5x3 мм, з нерівними краями, що кровоточить від дотику. Яка виразка, ймовірно, спостерігається?

- A. Декубітальна
- B. Трофічна
- C. Актиномікотична
- D. Сифілітична
- E. Туберкульозна

20. Лікар-хірург-стоматолог планує встановлення дентального імплантата пацієнту в ділянку відсутнього 36 зуба. Який вид анестезії буде оптимальним для контролю безпечності препарування кісткового ложе?

- A. Торусальна
- B. Інфільтраційна
- C. Ментальна
- D. Мандибулярна
- E. Туберальна

21. Під час огляду лікарем-стоматологом-ортодонтом п'ятирічного хлопчика виявлено зміщення серединної міжрізцевої лінії вліво, нестерті щічні горбики тимчасових молярів та ікла справа, що перекривають щічні горбики однойменних зубів верхньої щелепи. Із чого потрібно почати ортодонтичне лікування?

- A. Міогімнастичні вправи для колового м'яза рота
- B. Виготовлення ортодонтичного апарату

- С. Консультація логопеда та логопедична корекція
 Д. Рекомендації щодо жування на лівому боці щелепи
 Е. Пришліфування нестертих горбиків тимчасових зубів

22. Чоловік віком 57 років скаржиться на погіршення загального стану, сильний головний біль, підвищення температури тіла до 39°C, появу нудоти, блювання, задишки. На обличчі виражене почервоніння шкіри з чіткими нерівними обрисами, що підвищується над рівнем шкіри. Шкіра уражених ділянок набрякла, ущільнена на дотик, гладенька та блискуча. Піднижньощелепні лімфатичні вузли збільшені. Який імовірний діагноз?

- А. Бешиха
 В. Сибірка
 С. Стрептодермія
 Д. Червоний вовчак
 Е. Тромбофлебіт лицевої вени

23. Під час фіксації центрального співвідношення щелеп визначено умовний анатомічний орієнтир: лінію, яка проходить від точки на початку кісткової основи носової перегородки до середини козелка вуха. Як називається цей орієнтир?

- А. Трансверзальна крива Уілсона
 В. Франкфуртська горизонталь
 С. Камперівська горизонталь
 Д. Сагітальна крива Шпес
 Е. Оклюзійна площина

24. Жінка віком 56 років скаржиться на біль у передніх верхніх зубах після травми. Під час огляду у 12 та 11 зубах виявлено дефекти твердих тканин у межах емалі, рухомість цих зубів II ступеня. Зондування чутливе. Термодіагностика, перкусія болісні. Який додатковий метод обстеження буде найінформативнішим у цьому разі?

- А. Рентгенографія у прикус
 В. Прицільна рентгенографія
 С. Сканування поверхні зубів
 Д. Ортопантомограма
 Е. Комп'ютерна томографія

25. Жінка віком 47 років скаржиться на періодичне виникнення вивихів нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: прикус прямий, безперервність зубного ряду збережена. Під час відкривання рота відзначається клацання у скронево-нижньощелепному суглобі. Застосування

якого апарата дозволить попередити звичний вивих?

- А. Катца
 В. Оксмана
 С. Рудька
 Д. Лімберга
 Е. Петросова

26. Чоловік віком 52 роки скаржиться на руйнування зуба верхньої щелепи зліва. З анамнезу відомо, що зуб раніше покривався коронкою, якою пацієнт користувався 14 років. Об'єктивно спостерігається: 26 зуб зруйнований до ясенного краю, стійкий. На рентгенограмі патологічних змін у періапикальній ділянці 26 зуба не виявлено, кореневі канали запломбовані до верхівки, запальні процеси відсутні. Як найдоцільніше відновити анатомічну форму зуба?

- А. Анкерними штифтами і штампованою коронкою
 В. Видалити корінь із наступною імплантацією та протезуванням
 С. Куксовою вкладкою і штампованою коронкою
 Д. Анкерними штифтами і прямою реставрацією
 Е. Куксовою вкладкою і металокерамічною коронкою

27. У пацієнтки віком 46 років під час стоматологічного прийому за 40 хв після проведення місцевого знеболювання виникли захриплість голосу, 'гавкаючий' кашель, важкість дихання зі свистячими хрипами, задишка. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка неспокійна, метушлива, дихання шумне, стридорозне, обличчя ціанотичне зі щільним безболісним набряком повік, губ, носа. Який імовірний діагноз?

- А. Гостра серцево-судинна недостатність
 В. Напад бронхіальної астми
 С. Гостра дихальна недостатність
 Д. Анафілактичний шок
 Е. Набряк Квінке

28. У семирічної дівчинки під час огляду лікарем-стоматологом виявлено каріозну порожнину на жувальній поверхні 74 зуба. Встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 74 зуба, I клас за Блемом. Який пломбувальний матеріал в якості постійної пломби є найдоцільнішим у цій клінічній ситуації?

- А. Композит

В. Водний дентин

С. Силант

Д. Склоіономерний цемент

Е. Компомер

29. Жінка віком 45 років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, сухість слизової оболонки ротової порожнини та відчуття спраги, що турбують впродовж декількох місяців. Після об'єктивного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг. Яке додаткове дослідження треба призначити пацієнтці першочергово?

А. Рівень вітаміну С в крові

В. Рівень Fe в крові

С. Рівень Са в крові

Д. Рівень глюкози в крові

Е. Імунограму

30. Чоловік віком 42 роки скаржиться на больові відчуття від термічних та хімічних подразників, застрягання їжі у зубі нижньої щелепи зліва. Об'єктивно спостерігається: на медіальній поверхні 36 зуба каріозна порожнина нижче емалево-дентинного сполучення, виповнена слабопігментованим розм'якшеним дентином. Зондування дна порожнини безболісне, емалево-дентинної межі - чутливе, реакція на холод позитивна, швидко минає після усунення подразника. Перкусія безболісна. Який імовірний діагноз?

А. Гострий поверхневий карієс

В. Гострий глибокий карієс

С. Хронічний фіброзний пульпіт

Д. Хронічний середній карієс

Е. Гострий середній карієс

31. Чоловік віком 60 років звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда зі скаргами на незадовільну фіксацію повного знімного протеза на верхній щелепі, що був виготовлений 4 роки тому. Об'єктивно спостерігається: протез не щільно прилягає до протезного ложа верхньої щелепи, балансує, спадає під час розмови. Вкажіть тактику лікаря у цьому разі.

А. Корекція меж протеза

В. Провести перебазування лабораторним методом

С. Корекція прикусу

Д. Провести перебазування клінічним методом

Е. Виготовити новий протез

32. Жінка віком 23 роки на 7-му тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на різкий біль у зубі верхньої щелепи від холодкових подразників, що триває декілька хвилин. Діагностовано гострий обмежений пульпіт 24 зуба. Який знеболювальний засіб треба застосувати для проведення анестезії у цьому разі?

А. Бупівакаїн

В. Мепівакаїн

С. Новокаїн

Д. Артикаїн

Е. Лідокаїн

33. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 35 років для зубного протезування. Об'єктивно спостерігається: дефект зубного ряду III класу за Кеннеді на верхній щелепі справа, відсутні 14, 15 зуби. З анамнезу відомо, що пацієнтка має обтяжений алергологічний анамнез, зокрема алергію на кобальто-хромовий та хромо-нікелевий сплави, поліметилметакрилат. Який мостоподібний протез доцільно виготовити у цій клінічній ситуації?

А. Суцільнокерамічний

В. Металокерамічний

С. Металопластмасовий

Д. Адгезивний

Е. Штамповано-паяний

34. У пацієнта віком 23 роки під час профілактичного огляду лікарем-стоматологом виявлено недорозвиненість горбів перших молярів, зуби мають конусовидну форму. З анамнезу відомо: спадковий сифіліс. Якому діагнозу відповідає описана клінічна картина?

А. Зуби Гетчінсона

В. Зуби Пфлюгера

С. Недосконалий амелогенез

Д. Зуби Фурн'є

Е. Флюороз зубів

35. Пацієнту на прийомі у лікаря-стоматолога діагностовано генералізований пародонтит II ступеня тяжкості, хронічний перебіг. З анамнезу відомо: протезування клапана серця. Лікар планує проведення первинного пародонтологічного лікування, яке передбачає насамперед видалення над- та під'ясенних зубних відкладень. Які групи

препаратів мають бути призначені пацієнту для профілактики розвитку ендокардиту?

- A. Антибіотики для системного застосування**
- B. Знеболювальні засоби місцевої дії
- C. Антибіотики для місцевого застосування
- D. Знеболювальні засоби системної дії
- E. Протизапальні засоби місцевого застосування

36. Жінці віком 63 роки виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Лікар на готовий протез наніс тонкий шар силіконової відбиткової маси та ввів у ротову порожнину, запропонувавши пацієнтці виконати довільні рухи щокми, язиком, відкрити рот. Процедуру повторили кілька разів, після цього виготовили новий базис протеза. Для чого лікар виконував ці маніпуляції?

- A. Корекції висоти прикусу
- B. Покращення фіксації**
- C. Припасування
- D. Корекції країв
- E. Переробки протеза

37. Жінка віком 62 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття сухості у порожнині рота, зміну смаку, печіння язика, яке зменшується під час вживання їжі. З анамнезу відомо, що ці скарги з'явилися півроку тому, після психічної травми. Об'єктивно спостерігається: язик блідо-рожевого кольору, спинка вкрита незначною кількістю нальоту. Яке стоматологічне захворювання проявляється цими симптомами?

- A. Хронічний атрофічний кандидоз
- B. Глосит Гюнтера-Міллера
- C. Неврит язикового нерва
- D. Десквамативний глосит
- E. Глосодинія**

38. До лікаря-стоматолога звернулася дівчина віком 20 років зі скаргами на потемніння верхнього переднього зуба. З анамнезу відомо: випадок травми фронтальної групи зубів. Після проведення діагностики об'єктивно встановлено: зміна кольору коронки 11 зуба, тести на вітальність пульпи негативні, на прицільний рентгенограмі зміни відсутні. Який патологічний процес спостерігається у цьому разі?

A. -

- B. Резорбція кореня
- C. Облітерація кореневого каналу
- D. Некроз пульпи**
- E. Дисколорація зуба

39. Чоловік віком 25 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткочасний біль у зубі нижньої щелепи справа під час вживання солодкого, гарячого, холодного. Об'єктивно спостерігається: на медіальній поверхні 46 зуба каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, виповнена світлим, розм'якшеним дентином. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія зуба безболісна. ЕОД - 11 мкА. Термопроба позитивна, реакція зникає відразу після припинення дії подразника. Який імовірний діагноз?

- A. Хронічний фіброзний пульпіт
- B. Гіперемія пульпи
- C. Гострий середній карієс
- D. Гострий глибокий карієс**
- E. Хронічний фіброзний періодонтит

40. У чоловіка віком 83 роки на кінчику носа розташоване горбисте новоутворення до 3 см у діаметрі, м'яке, безболісне, з блискучою сальною поверхнею, багряно-синюшного кольору. Під час пальпації сальні залози виділяють шкірне сало з неприємним запахом. Установіть попередній діагноз.

- A. Невринома
- B. Ліпома
- C. Атерома
- D. Фіброма
- E. Ринофіма**

41. Жінка віком 46 років на прийомі у лікаря-стоматолога після введення анестетика поскаржилася на загальну слабкість, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: блідість та ціаноз шкіри, холодний липкий піт, дихання часте поверхневе, пульс ниткоподібний, свідомість сплутана, АТ - 80/50 мм рт.ст. Який імовірний діагноз?

- A. Інсульт
- B. Анафілактичний шок
- C. Гіпертонічний криз
- D. Колапс**
- E. Гіпоглікемічна кома

42. На прийомі в лікаря-стоматолога під час препарування зубів жінка віком 59 років знепритомніла. Об'єктивно

спостерігається: зіниці розширені, не реагують на світло, відсутні дихання та пульс на сонних артеріях. Пацієнтці надається невідкладна допомога. У якому співвідношенні треба виконувати непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень?

- A. 30:2
- B. 40:2
- C. 15:1
- D. 15:2
- E. 20:2

43. Жінка віком 42 роки скаржиться на підвищену чутливість деяких зубів від кислого та холодного. Об'єктивно спостерігається: у пришийковій ділянці 13, 23, 14, 24 зубів дефекти твердих тканин із гладкими, блискучими, щільними стінками, що сходяться під кутом, не змінені у кольорі. Встановіть діагноз.

- A. Клиноподібний дефект
- B. Гіпоплазія емалі
- C. Пришийковий некроз
- D. Хронічний середній карієс
- E. Ерозія емалі

44. Батьки шестирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу у дитини проміжків між зубами. Під час обстеження виявлено тріси і діастеми між зубами та стертість ріжучих країв та горбиків. Що можна запропонувати цьому пацієнту?

- A. Міогімнастику
- B. Не потребує лікування
- C. Не вживати тверду їжу
- D. Вибіркове пришліфовування
- E. Апаратурне лікування

45. Під час проведення операції видалення зуба пацієнт випадково вдихнув марлевий тампон. Виникло різке порушення дихання, кашель. Який тип асфіксії розвивається у цьому разі?

- A. Обтураційна
- B. Дислокаційна
- C. Аспіраційна
- D. Стенотична
- E. Клапанна

46. Ідіопатичні захворювання включають синдроми з прогресуючим лізисом тканин пародонта. Яка з наведених нижче хвороб не належить до цих захворювань?

- A. Таратинова

- B. Леттерера-Зіве
- C. Папійона-Лефевра
- D. Хенда-Шюллера-Крісчена
- E. Педжета

47. Чоловік віком 54 роки після травми скаржиться на кровотечу з носа, порушення чутливості верхньої губи справа, деформацію обличчя, обмеження відкривання рота. Під час пальпації кісток лицевого скелета спостерігається симптом 'сходінки' по нижньому краю орбіти та у ділянці вилично-альвеолярного гребеня справа. Рентгенологічно визначається завуальованість верхньощелепного синуса справа. Який імовірний діагноз?

- A. Перелом верхньої щелепи по Лефор-III
- B. Перелом верхньої щелепи по Лефор-II
- C. Перелом верхньої щелепи по Лефор-I
- D. Перелом кісток носа
- E. Перелом виличної кістки справа

48. У чоловіка віком 42 роки під час стоматологічного огляду виявлено: ксеростомію, множинний карієс зубів, генералізований пародонтит II ступеня, катаральний глосит. Пацієнт відмічає іноді парестезію язика, підвищену спрагу. На тлі якої групи захворювань виникають ці зміни у порожнині рота?

- A. Ендокринної системи
- B. -
- C. Серцево-судинної системи
- D. Шлунково-кишкового тракту
- E. Гіпо-і авітамінозів

49. Жінка віком 51 рік скаржиться на набряклість у піднижньощелепній ділянці справа, що виникає під час вживання їжі та за 2-3 год поступово зникає. На рентгенограмі дна порожнини рота виявлено рентгенконтрастну тінь подовженої форми, розміром 0,5x0,2 см, що розташована паралельно до тіла нижньої щелепи у проєкції 45 та 44 зубів. Який імовірний діагноз?

- A. Специфічний сіалоаденіт
- B. Лімфаденіт піднижньощелепної ділянки
- C. Набряк Квінке
- D. Аденома слинної залози
- E. Слинокам'яна хвороба

50. Пацієнту віком 54 роки встановлено діагноз: синдром Костена. Якою патологією СНЩС зумовлене це захворювання?

- A. Больовою дисфункцією

- В. Артритом
- С. Анкілозом
- Д. Посттравматичними проявами
- Е. Артрозом

51. Чоловік віком 58 років скаржиться на сухість та печіння у порожнині рота, що посилюються під час вживання їжі. З анамнезу відомо: пацієнт хворіє на цукровий діабет та невроз, що виник 3 місяці тому. Об'єктивно спостерігається: СОПР гіперемована, набрякла, спинка язика вкрита білуватим нальотом, який частково легко знімається. Слина тягнеться нитками за шпателем. Укажіть імовірний діагноз.

- А. Хронічний кандидоз
- В. Червоний плоский лишай
- С. Десквамативний глосит
- Д. Лейкоплакія
- Е. Глосодинія

52. Сімнадцятирічний юнак скаржиться на незвичний вигляд ясен. Об'єктивно спостерігається: маргінальний край вестибулярної поверхні ясен блідо-рожевого кольору, валикоподібно потовщений. Ясенні сосочки округлої форми, перекривають коронкові частини всіх зубів майже на 1/3 їх висоти, кровоточивість відсутня. На рентгенограмі верхньої та нижньої щелеп патологічних змін не виявлено. Який імовірний діагноз?

- А. Загострення катарального гінгівіту
- В. Фіброматоз ясен
- С. Генералізований пародонтит I ступеня
- Д. Хронічний катаральний гінгівіт
- Е. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

53. Жінка віком 60 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на значну сухість у порожнині рота. З анамнезу відомо, що жінка 4 роки хворіє на системний червоний вовчак, кератокон'юнктивіт та хронічний паренхіматозний паротит. Для якого синдрому характерні ці симптоми?

- А. Робена
- В. Костена
- С. Мелькерсона-Розенталя
- Д. Бехчета
- Е. Шегрена

54. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на ниючий біль у ділянці лівого СНЩС, скутість у суглобі зранку, відчуття закладеності у лівому вусі. Під час внутрішньоротового огляду виявлено

часткову адентію. На рентгенограмі СНЩС спостерігається: суглобова щілина місцями різко звужується, суглобовий горбик згладжений, глибина суглобової ямки зменшена, суглобові поверхні не рівні. Яку патологію СНЩС можна діагностувати у цьому разі?

- А. Артроз
- В. Больову дисфункцію
- С. Хронічний артрит
- Д. Анкілоз
- Е. Гострий артрит

55. Пацієнту віком 40 років встановлено попередній діагноз: лімфома Ходжкіна. Для підтвердження діагнозу було проведено біопсію ураженого лімфатичного вузла з подальшим гістологічним дослідженням. Наявність яких клітин підтверджує правильність попереднього діагнозу?

- А. Пирогова-Лангханса
- В. Ксантомних
- С. Боткіна-Гухпрехта
- Д. Березовського-Штернберга
- Е. Яворського

56. До лікаря-стоматолога-ортопеда звернувся чоловік віком 37 років зі скаргами на часте випадіння пломби із зуба нижньої щелепи справа. Об'єктивно спостерігається: у 46 зубі дефект твердих тканин II класу за Блемом з руйнуванням медіальних горбів, залишки пломбувального матеріалу. ІРОПЗ становить 0,55. Яку конструкцію зубного мікропротеза треба використати у цьому разі?

- А. Overlay
- В. Pinlay
- С. Veneer
- Д. Onlay
- Е. Inlay

57. Дівчина віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний дефект та порушення функції вживання їжі. Об'єктивно спостерігається: губи не змикаються, між фронтальними зубами і частково премоллярами верхньої та нижньої щелеп наявна вертикальна щілина до 0,5 см, оклюзійний контакт є лише на молярах. Яку аномалію розвитку виявлено у пацієнтки?

- А. Прогенія
- В. Косий прикус

- C. Макрогнатія
- D. Перехресний прикус
- E. **Відкритий прикус**

58. Чоловік віком 32 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на руйнування переднього зуба верхньої щелепи. Після огляду та клінічного обстеження встановлено діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 22 зуба. Показано видалення зуба. Виберіть анестезію для ефективного знеболювання.

- A. **Різцева, інфраорбітальна**
- B. Різцева
- C. Туберальна, піднебінна
- D. Туберальна
- E. Торусальна, щічна

59. Пацієнту віком 60 років встановлено діагноз: генералізована патологічна стертість зубів. Об'єктивно спостерігається: зменшення висоти коронок зубів на 1/2, зниження висоти прикусу. Який метод лікування є найраціональнішим?

- A. **Відновлення висоти прикусу ортопедичними методами**
- B. Відновлення анатомічної форми зубів композитними матеріалами
- C. Відновлення анатомічної форми зубів склоіономерними цementsами
- D. Відновлення висоти зубів за допомогою парапульпарних штифтів та композитних матеріалів
- E. Відновлення висоти зубів за допомогою внутрішньокореневих анкерних штифтів та композитних матеріалів

60. Після атипового видалення 48 зуба у пацієнта спостерігається парастезія у ділянці правої половини нижньої губи та підборіддя. Під час обстеження на ЕОД виявлено зниження електрозбудливості пульпи зубів нижньої щелепи справа. Який імовірний діагноз?

- A. **Неврит правого нижньоальвеолярного нерва**
- B. Невралгія правого нижньоальвеолярного нерва
- C. Гострий остеомієліт тіла нижньої щелепи
- D. Оперізуючий лишай
- E. Альвеоліт

61. Жінка віком 58 років скаржиться на відсутність 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47 зубів. Зуби, які залишилися, мають рухомість I

ступеня. На ортопантограмі у ділянці 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів спостерігається резорбція альвеолярного відростка у межах 1/3 висоти міжзубних перетинок. Яку ортопедичну конструкцію доцільно запропонувати пацієнтці?

- A. Шину Ельбрехта
- B. Частковий знімний пластинковий протез
- C. Напівкоронкову шину
- D. **Бюгельну шину-протез**
- E. Шину на скловолоконній стрічці

62. До лікаря-стоматолога звернулися батьки дев'ятирічної дівчинки зі скаргами на біль у фронтальній ділянці верхньої щелепи та відсутність зуба у дитини через травму обличчя під час спортивних змагань. Об'єктивно спостерігається: 11 зуб відсутній, 21 зуб зміщений у бік відсутнього 11 зуба. На рентгенограмі виявлено розширення періодонтальної щілини 21 зуба. Який імовірний діагноз?

- A. Неповний вивих 11 зуба, перелом коронки 21 зуба
- B. Вбитий вивих 11 зуба, повний вивих 21 зуба
- C. Вбитий вивих 21 зуба, повний вивих 11 зуба
- D. Повний вивих 21 зуба, перелом кореня 11 зуба
- E. **Повний вивих 11 зуба, неповний вивих 21 зуба**

63. У пацієнтки в ході видалення атипово розташованого 38 зуба відбувся відлам його коронкової частини. Під час подальших дій за допомогою щипців, елеватора та синдесмотома видалити корені зуба не вдалося. Які маніпуляції має здійснити лікар-стоматолог-хірург для успішного видалення коренів зуба?

- A. Застосувати елеватор Леклюза
- B. **Роз'єднати корені за допомогою фізіодиспенсера та фісурного бора**
- C. -
- D. Завершити видалення під час наступного відвідування
- E. Застосувати елеватор Вінтера

64. Пацієнт віком 55 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у порожнині рота. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлено множинні ерозії застійно-червоного кольору, що зливаються між собою. Навколишня слизова ареактивна. Симптом

Нікольського позитивний. Під час цитологічного дослідження виявлено клітини Тцанка. Установіть діагноз.

- A. Багатоформна ексудативна еритема
- B. **Пухирчатка**
- C. Гострий герпетичний стоматит
- D. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- E. Оперізуючий лишай

65. Дівчина віком 20 років звернулася до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. Об'єктивно спостерігається: конфігурація обличчя порушена через недорозвинення нижньої третини обличчя, зменшення висоти нижньої третини обличчя, підборіддя зміщено дистально, глибоке різцеве перекриття. Яку аномалію розвитку виявлено у пацієнтки?

- A. **Мікрогенія**
- B. Прогенія
- C. Макрогенія
- D. Макрогенія
- E. Прогнатія

66. Під час клінічного обстеження порожнини рота семирічного хлопчика лікарем-стоматологом виявлено низько прикріплену вуздечку верхньої губи. До якої аномалії це може призвести?

- A. Адентії
- B. Транспозиції
- C. Інфраоклюзії
- D. Тортоаномалії
- E. **Діастеми**

67. Що у конструкції ортодонтичного апарата має ознаки елементів функціонально-направляючої дії?

- A. Гвинт для розширення
- B. Вестибулярна дуга
- C. Базис апарата
- D. **Похила площина**
- E. Рукоподібні пружини

68. Пацієнту віком 67 років показано виготовлення повного знімного протеза для верхньої щелепи. Лікар-стоматолог-ортопед вирішив виготовити індивідуальну ложку за методом ЦІТО. Який матеріал він використає?

- A. **Базисний віск**
- B. Фотополімерну пластину
- C. Полістиролову пластину
- D. Самотвердіючу пластмасу

E. Базисну пластмасу

69. Жінка віком 32 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: ясна верхньої та нижньої щелеп гіперемовані з ціанотичним відтінком, набряклі. Пародонтальні кишені - 3,5 мм. На ортопантомограмі виявлено резорбцію міжальвеолярних перетинок до 1/3 їх висоти. Установіть діагноз.

- A. **Генералізований пародонтит I ступеня**
- B. Генералізований пародонтит II ступеня
- C. Гіпертрофічний гінгівіт
- D. Пародонтоз I ступеня
- E. Пародонтоз II ступеня

70. З якої процедури необхідно розпочинати місцеве лікування пацієнта, який хворіє на виразково-некротичний гінгівіт?

- A. Усунення місцевих травматичних чинників
- B. **Знеболення слизової оболонки порожнини рота**
- C. Повне зняття зубних нащарувань
- D. Антисептична обробка ротової порожнини
- E. Кератопластична терапія

71. Жінка віком 44 роки скаржиться на напади самовільного болю у ділянці верхньої щелепи зліва, що тривають по 2-3 год, посилюються вночі та від дії холодних подразників. Біль турбує протягом 2-х днів. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 25 зуба каріозна порожнина у межах біляпульпарного дентину. Зондування болюче по всьому дну. ЕОД = 30 мкА. Який імовірний діагноз?

- A. **Гострий дифузний пульпіт**
- B. Гострий глибокий карієс
- C. Невралгія трійчастого нерва
- D. Гострий серозний періодонтит
- E. Гострий гнійний пульпіт

72. Батьки десятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на скупченість зубів у фронтальній ділянці у дитини. Під час обстеження виявлено мілкий присінок порожнини рота до 3 мм висотою. Яке оперативне втручання буде рекомендовано пацієнту?

- A. Френулотомія
- B. Остеопластика

- С. Гінгівопластика
- D. Вестибулопластика**
- Е. Френулопластика

73. Чоловік віком 56 років скаржиться на шорсткість слизової оболонки порожнини рота у ділянці щік та язика. Об'єктивно спостерігається: висипання на слизовій оболонці щік ретромолярної ділянки у вигляді сіро-білих папул із нальотом, які зливаються у кільця та дуги. Під час пальпації регіонарних лімфоузлів патологічних змін не виявлено. Який попередній діагноз?

- А. Хронічний кандидоз
- В. Червоний вовчак
- С. Лейкоплакія
- D. Червоний плоский лишай**
- Е. Вторинний сифіліс

74. Жінка віком 56 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровоточивість ясен. Під час об'єктивного обстеження лікар вирішив провести пародонтальний скринінг-тест (PSR). Який критерій є визначальним для встановлення ступеня тяжкості патології пародонта?

- A. Глибина зондування**
- В. Рухомість зубів
- С. Кровоточивість
- D. Ступінь рецесії
- Е. Зубні відкладення

75. Юнак віком 18 років скаржиться на біль у ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Зі слів пацієнта, він отримав побутову травму 2 дні тому. Об'єктивно спостерігається: садна у ділянці верхньої губи, зубний ряд інтактний, рухомість 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів I ступеня. Після рентгенологічного дослідження встановлено діагноз: перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи у ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів. Яку шину для постійної фіксації треба накласти у цьому разі?

- A. Гладку шину-скобу**
- В. Шину Порта
- С. Шину Лімберга
- D. Шину з розпірковим вигином
- Е. Шину із зачіпними петлями

76. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 37 років зі скаргами на періодичний біль у фронтальному відділі верхньої щелепи. З анамнезу відомо, що 22 зуб раніше був лікований у зв'язку з пульпіту. Об'єктивно спостерігається:

коронка 22 зуба відреставрована композитним пломбувальним матеріалом. На рентгенограмі виявлено деструкцію кісткової тканини у ділянці верхівки кореня 22 зуба діаметром до 1 см. Кореневий канал запломбований до верхівки. Встановлено попередній діагноз: хронічний гранулематозний періодонтит і кістогранульома 22 зуба. Виберіть методику лікування.

- А. Розріз по перехідній складці
- В. Резекція верхівки кореня 22 зуба з цистектомією**
- С. Консервативне медикаментозне лікування
- D. Реплантація 22 зуба
- Е. Видалення 22 зуба

77. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт, якому три дні тому було проведено перикоронаротомію у ділянці 38 зуба, зі скаргами на різке обмеження відкривання рота, біль під час ковтання, парестезію підборіддя зліва, загальну слабкість, підвищену температуру тіла. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, контрактура III ступеня, підщелепні лімфовузли збільшені, болісні. Під час пальпації виникає різкий біль у ділянці внутрішньої поверхні кута нижньої щелепи. У ділянці розтину - гіперемія та набряк слизової оболонки, що переходить на крило-щелепну складку. Який імовірний діагноз?

- А. Гострий остеомієліт нижньої щелепи
- В. Паратонзиллярний абсцес зліва
- С. Флегмона біляглоткового простору
- D. Флегмона крило-щелепного простору**
- Е. Абсцес щелепно-язикового жолобка

78. Чоловік віком 75 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий біль у зубі верхньої щелепи. З анамнезу відомо: пацієнт знаходиться на обліку у кардіологічному відділенні. Після проведеної місцевої анестезії у нього виникли ознаки гострої серцевої недостатності, біль у грудях. Яка тактика лікаря-стоматолога у цьому разі?

- А. Екстракт валеріани
- В. Вдихання 10%-м розчином аміаку
- С. 1-2 краплі фармадипіну під язик
- D. Непрямий масаж серця, виклик екстеної (швидкої) медичної допомоги
- Е. Нітрогліцерин, виклик екстеної (швидкої) медичної допомоги**

79. Тринадцятирічний хлопчик скаржиться на естетичний дефект у вигляді плями на верхньому передньому зубі. Об'єктивно спостерігається: на емалі вестибулярної поверхні у ділянці ріжучого краю 21 зуба пляма білого кольору з чіткими межами, гладка під час зондування, під час висушування у розмірах не змінюється. Установіть попередній діагноз.

- A. Системна гіпоплазія емалі
- B. Ендемічний флюороз
- C. Хронічний поверхневий карієс
- D. Гострий початковий карієс
- E. Місцева гіпоплазія емалі

80. Восьмирічна дівчинка скаржиться на перелом коронки та біль у лівому верхньому фронтальному зубі, що виникли через травму близько двох годин тому. Об'єктивно спостерігається: коронкова частина 21 зуба відсутня на 1/3, пульпа оголена в одній точці, різко болюча та кровоточить під час зондування, перкусія зуба дещо болісна. Дитина практично здорова, КПВ+кп=3. Яка тактика лікування найдоцільніша у цій клінічній ситуації?

- A. Біологічний метод
- B. Девітальна екстирпація
- C. Вітальна ампутація
- D. Вітальна екстирпація
- E. Девітальна ампутація

81. Жінка віком 25 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий біль у зубі верхньої щелепи. Після проведення огляду у пацієнтки з'явилася слабкість, дзвін у вухах, запаморочення, блідість шкірних покривів, потовиділення на шкірі лоба та підборідді, втрата свідомості до 1 хвилини. АТ - 90/60 мм рт. ст. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Епілептичний напад
- B. Гіперглікемічна кома
- C. Колапс
- D. Непритомність
- E. Гіпертонічний криз

82. Пацієнт віком 61 рік скаржиться на утруднене відкривання рота внаслідок забою СНЩС та біль у ділянці третього моляру нижньої щелепи. Яка техніка знеболювання буде доцільна у цьому клінічному випадку для розблокування щелепи?

- A. За Вейсблатом
- B. За Гоу-Гейтсом

- C. За Вазірані-Акінозі
- D. За Вейсбремом
- E. -

83. Чоловік віком 64 роки звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда зі скаргами на наявність дефекту носа, часті застудні захворювання, виливання рідини крізь ніс під час вживання їжі. З анамнезу відомо, що дефект утворився через травму. Об'єктивно спостерігається: повна відсутність хрящової та кісткової тканин носа. Залишилися перегородка та носові ходи. Планується виготовлення ектопротеза носа. Виберіть відбитковий матеріал для зняття орієнтовного відбитка у цій клінічній ситуації.

- A. Упін
- B. Стенс
- C. Репін
- D. Сілафлекс
- E. Гіпс

84. Пацієнт віком 22 роки, який працює у дорожній службі, скаржиться на сухість, болісність, лущення губ у літній період. Об'єктивно спостерігається: червона облямівка губ набрякла, гіперемована, укрита дрібними лусочками і тріщинами. Який засіб доцільно призначити під час лікування для захисту червоної облямівки губ?

- A. Фотозахисна мазь
- B. Антигістамінні препарати
- C. Антисептичні розчини
- D. Протизапальні суспензії
- E. Зволожуючий гель

85. Дівчина віком 16 років скаржиться на кровоточивість та болючість ясен. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен набрякла, гіперемована, ясенні сосочки вкриті сірим некротичним нальотом. Регіональні лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації. Установіть імовірний діагноз.

- A. Виразковий гінгівіт
- B. Локалізований пародонтит
- C. Атрофічний гінгівіт
- D. Катаральний гінгівіт
- E. Гіпертрофічний гінгівіт

86. Після пломбування кореневих каналів 46 зуба, що лікувався з приводу гострого гнійного пульпіту, пацієнта віком 57 років непокоїть біль, що посилюється під час накушування на зуб. На рентгенограмі виявлено: кореневі канали 46 зуба

обтуровані пломбувальним матеріалом на всю довжину, періодонтальна щілина рівномірно розширена. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога?

A. Проведення фізіотерапевтичних процедур

B. Розкриття кореневого каналу

C. Видалення зуба

D. Призначення антибіотикотерапії

E. Резекція верхівки кореня зуба

87. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на наявність білих плям на всіх групах зубів, що спостерігаються з моменту їх прорізування. Під час огляду на всіх зубах виявлено плями білого кольору з нечіткими межами, що не забарвлюються метиленовим синім. Сім'я проживала у районі з вмістом фтору у питній воді 3,5 мг/л. Установіть імовірний діагноз.

A. Недосконалий амелогенез

B. Ендемічний флюороз

C. Системна гіпоплазія емалі

D. Недосконалий дентиногенез

E. Гострий початковий карієс

88. Жінка віком 43 роки скаржиться на появу безболісної симетричної червоної плями, розташованої в центральній частині обличчя, що охоплює щоки та крила носа. З анамнезу відомо, що подібні симптоми виникають періодично в осінньо-літній період. Під час обстеження на шкірі обличчя виявлено еритему, запала центральна частина якої вкрита лусочками, а по периферії - блідо-червона смужка вільна від лусочок з ділянками гіперкератозу різної величини та валиком папульозного інфільтрату. Установіть попередній діагноз.

A. Хвороба Боуена

B. Червоний вовчак

C. Оперізувальний лишай

D. Бешиха

E. Багатоформна ексудативна еритема

89. У пацієнта віком 26 років, який захворів 3 дні тому, спостерігається підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, загальна слабкість. Під час огляду на шкірі тильної поверхні верхніх кінцівок виявлено чітко відмежовані округлі папули рожевого кольору, у порожнині рота численні ерозії, кров'яністі кірки на губах. Симптом Нікольського негативний. Який попередній діагноз?

A. Стоматит Венсана

B. Червоний плоский лишай

C. Гострий герпетичний стоматит

D. Пухирчатка

E. Багатоформна ексудативна еритема

90. Батьки восьмирічного хлопчика скаржаться на підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, млявість та біль у горлі дитини. Об'єктивно спостерігається: гострий катаральний стоматит, мигдалики набряклі, гіперемовані, вкриті жовто-сірим нальотом, що легко знімається. Підщелепні, шийні, потиличні лімфовузли значно збільшені, слабоболючі під час пальпації. За результатами лабораторного дослідження виявлено лейкоцитоз і атипові мононуклеари. Укажіть етіологічний чинник захворювання.

A. Вірус Епштейна-Барр

B. Гемолітичний стрептокок

C. Вірус простого герпесу

D. Паличка Борде-Жангу

E. Вірус Коксаки

91. Шестирічна дівчинка скаржиться на ниючий біль у зубі нижньої щелепи справа, який викликають хімічні та термічні подразники. Об'єктивно спостерігається: на апроксимально-медіальній поверхні 85 зуба каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину, що точково сполучається з пульповою камерою зуба. Зондування сполучення болісне, реакція на термічні подразники тяж болісна і тривала. Встановіть імовірний діагноз.

A. Хронічний гранулюючий періодонтит

B. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

C. Хронічний гангренозний пульпіт

D. Гострий обмежений пульпіт

E. Хронічний фіброзний пульпіт

92. Жінка віком 56 років скаржиться на наявність поодинокого новоутворення на шкірі лівої щоки, що з'явилося близько 3 років тому. Об'єктивно спостерігається: на шкірі лівої щоки шароподібне новоутворення діаметром 0,4 см із зернистою поверхнею, сіруватого кольору, без волосяного покриву, безболісне під час пальпації, м'яке на дотик і легко рухається відносно шкіри. Який попередній діагноз?

A. Бородавка

B. Базаліома

C. Нейрофіброма

D. Папілома

E. Шкірний ріг

93. Жінка віком 26 років скаржиться на естетичний дефект через руйнування передніх верхніх зубів. Під час огляду на контактних поверхнях 21 та 22 зубів виявлено дефекти твердих тканин у межах плащового дентину з пігментованим щільним дном. Зондування, термодіагностика, перкусія безболісні. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 1,2. Який матеріал доцільно використати для пломбування дефектів?

- A. Органоцемент
- B. Наногібридний композитний**
- C. СІЦ
- D. Макрогібридний композитний
- E. Компомер

94. Під час операції направленої кісткової регенерації використано замісники, синтезовані на основі фосфату кальцію. Яку назву мають ці матеріали?

- A. Ксеногенні
- B. Алопластичні**
- C. Алогенні
- D. Колагенові мембрани
- E. Аутогенні

95. Десятирічний хлопчик скаржиться на біль під час їжі у зубі на верхній щелепі справа. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 16 зуба каріозна порожнина в межах світлого розм'якшеного навколопульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини слабко болісне, від холодового подразника виникає короткотривалий біль, що зникає відразу після усунення подразника. Який попередній діагноз?

- A. Гострий обмежений пульпіт
- B. Гострий глибокий карієс**
- C. Гострий середній карієс
- D. Хронічний глибокий карієс
- E. Хронічний фіброзний пульпіт

96. Хлопець віком 18 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність естетичних дефектів зубів. Під час огляду на вестибулярних поверхнях пришийкових ділянок всіх зубів виявлено крейдоподібні плями, терміни існування яких пацієнт не може визначити. Спостерігається хронічний катаральний гінгівіт легкого ступеня. Попередній діагноз: множинний початковий карієс. Виберіть метод дослідження, який допоможе встановити остаточний діагноз.

- A. Рентгенографія

- B. Холодовий тест
- C. ЕОД
- D. Визначення індексу гігієни
- E. Вітальне забарвлення зубів**

97. Чоловік віком 50 років скаржиться на наявність новоутворення на верхній губі. Об'єктивно на шкірі верхньої губи спостерігається одиночний вузол гіперкератозу, що підвищується над рівнем навколишніх тканин, конічної форми, діаметром 0,4 см, безболісний під час пальпації, сірого кольору, має пошарову будову. Установіть попередній діагноз.

- A. Кератоакантома
- B. Хвороба Боуена
- C. Папілома
- D. Бородавчастий передрак
- E. Шкірний ріг**

98. Чоловік віком 26 років скаржиться на незвичний вигляд язика. Об'єктивно на поверхні язика спостерігається велика кількість складок, що розташовані асиметрично у поздовжньому і поперечному напрямках. Дно і бокові поверхні складок вкриті сосочками, що характерні для нормальної слизової оболонки язика. Який імовірний діагноз?

- A. Волосатий язик
- B. Складчастий язик**
- C. Ромбовидний глосит
- D. Глосидинія
- E. Десквамативний глосит

99. Наявність якого захворювання у пацієнта є важливою діагностичною ознакою синдрому Бехчета?

- A. Афтозного стоматиту**
- B. Виразково-некротичного стоматиту
- C. Катарального стоматиту
- D. Атрофічного кандидозу
- E. Гіперпластичного кандидозу

100. Під час первинного огляду восьмирічної дівчинки спостерігається: обличчя дитини подовжене, напіввідкритий рот, широке перенісся, нерухомі крила носа. Про порушення якої функції свідчить виявлений симптомокомплекс?

- A. Жування
- B. Дихання**
- C. Мовлення
- D. Змикання губ
- E. Ковтання

101. Під час прийому пацієнта із наркотичною залежністю лікар-стоматолог випадково вколовся голкою шприца для анестезії. У який термін необхідно провести лабораторні методи обстеження для виявлення ВІЛ-інфекції?

- A. Не раніше ніж за 3-6 місяців
- B. -
- C. Протягом першого місяця
- D. Не раніше ніж за рік
- E. Протягом другого місяця

102. У стоматологічну клініку звернулися батьки із семирічним хлопчиком зі скаргами на неправильне положення зубів у дитини. Під час зовнішньоротового обстеження змін не виявлено. Об'єктивно спостерігається: співвідношення перших постійних молярів - I клас за Енглем, верхні фронтальні зуби нахилені вперед і перекривають нижні на 2/3 висоти коронок зубів, проміжок 5 мм між 11 та 21 зубами. Під час пальпації альвеолярного відростка з вестибулярної сторони визначається ущільнення опуклої форми. Що може спричинити формування проміжку між 11 та 21 зубами?

- A. Раннє прорізування центральних різців
- B. Надкомплектний зуб
- C. Інфантильний тип ковтання
- D. Шкідлива звичка гризти нігті
- E. Шкідлива звичка закусувати нижню губу

103. Пацієнтка віком 47 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та почервоніння у ділянці металокерамічного мостоподібного протеза, виготовленого 2 місяці тому, після фіксації якого з'явилися вищенаведені скарги. Об'єктивно спостерігається: у ділянці проміжної частини мостоподібного протеза з опорою на 43 і 46 зуб слизова оболонка гіперемована, набрякла, місцями пошкоджена, кровоточить від дотику. Якої помилки припустилися під час виготовлення протеза?

- A. Перевантаження опорних зубів
- B. Відсутність множинних оклюзійних контактів
- C. Неправильне моделювання проміжної частини
- D. Неякісне лиття металевих каркасів
- E. Неправильне моделювання горбиків штучних зубів

104. У чотирирічного хлопчика під час профілактичного стоматологічного огляду виявлено дефекти емалі на вестибулярних поверхнях 52, 51, 61, 62 зубів. Дефекти мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. Поверхня дефектів шорстка та крихка під час зондування. Дитина контактна. Визначте подальшу лікувальну тактику.

- A. Герметизація фісур
- B. Імпрегнація нітратом срібла
- C. Спостереження у динаміці
- D. Проведення ремтерапії
- E. Пломбування дефектів

105. Жінка віком 42 роки скаржиться на біль від температурних і хімічних подразників та наявність дефектів у 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубах. Об'єктивно спостерігається: дефекти поверхневі, овальної форми, розташовані на опуклій частині вестибулярної поверхні коронок, з гладеньким щільним дном. В анамнезі тиреотоксикоз. Який імовірний діагноз?

- A. Ерозія твердих тканин зуба
- B. Клиноподібний дефект
- C. Променевий некроз зубів
- D. Множинний карієс
- E. Хімічний некроз емалі

106. Під час клінічного обстеження тринадцятирічної дівчинки лікарем-стоматологом виявлено відсутність постійних других премолярів у зубній дузі верхньої щелепи. Який метод дослідження треба призначити насамперед для підтвердження клінічного діагнозу?

- A. Спірографію
- B. Вивчення мовної функції
- C. Фотометрію
- D. Аналіз діагностичних моделей
- E. Рентгенологічне

107. У пацієнта віком 20 років діагностовано утруднене прорізування 48 зуба. Лікар визначив абсолютне показання для видалення після проведення рентгенологічного методу дослідження, де виявив півмісяць Васмунда. Які рентгенологічні ознаки цього утворення?

- A. Розрідження кісткової тканини на верхівці кореня нижнього третього моляра
- B. Розрідження кісткової тканини в ділянці гілки нижньої щелепи

- С. Розрідження кісткової тканини в ділянці біфуркації коренів нижнього третього моляра
- D. Розрідження кісткової тканини позаду коронки нижнього третього моляра**
- Е. Косе положення, медіальний нахил нижнього третього моляра

108. Дівчина віком 22 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття печії на язичі під час вживання гострої та солоної їжі. З анамнезу відомо: пацієнтку періодично турбує біль у шлунку. Об'єктивно спостерігається: на спинці язика ділянки злущування епітелію ниткоподібних сосочків червоного кольору, оточених незначним кератозом у вигляді вузької білястої смужки. Установіть стоматологічний діагноз.

- А. Ромбоподібний глосит
- В. Складчастий язик
- С. Волосатий язик
- D. Десквамативний глосит**
- Е. Глосодинія

109. Під час профілактичного огляду дівчини віком 17 років лікар-стоматолог виявив утворення надлишкової емалі округлої форми діаметром 3 мм у пришийковій ділянці 24 зуба, що відокремлене від основної емалі зуба пластом цементу. З анамнезу відомо: це утворення було на зубі з моменту прорізування. Який імовірний діагноз?

- А. Гіперцементоз
- В. Недосконалий амелогенез
- С. Недосконалий дентиногенез
- D. Гіперплазія емалі**
- Е. Гіпоплазія емалі

110. Дівчина віком 16 років скаржиться на естетичний недолік зубів у вигляді множинних білих плям. Об'єктивно спостерігається: на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці ікол та різців верхньої та нижньої щелеп крейдоподібні тьмяні плями з нерівними контурами. Рівень гігієни задовільний. Після обстеження встановлено діагноз: гострий початковий карієс зубів. Який метод лікування буде найдоцільнішим?

- A. Інфільтрація Icon**
- В. Гліцерофосфат кальцію всередину
- С. Препарування і пломбування композитним матеріалом
- D. Препарування і пломбування СЩ
- Е. Професійна гігієна

111. Хлопець віком 21 рік скаржиться на помірний біль у горлі, підвищення температури тіла, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: м'яке піднебіння та піднебінні дужки набряклі, слабо гіперемовані з синюшним відтінком. На мигдаликах виявлено сірувато-білі плівки нальоту, щільно спаяні з поверхнею, зняття яких супроводжується кровотечею. Який збудник найімовірніше буде виявлено під час мікроскопії матеріалу з вогнища ураження?

- А. Гемолітичний стрептокок
- В. Фузоспірилярний симбіоз
- С. Стафілокок
- D. Паличка Леффлера**
- Е. Мікобактерія Коха

112. Під час одержання відбитка альгінатною масою з верхньої щелепи у пацієнта раптово виникли прискорене та поглиблене дихання, збудження, пітливість. Лікар негайно нахилив голову пацієнта донизу і вийняв відбиткову ложку з відбитковою масою, але шматок альгінатної маси потрапив у верхні дихальні шляхи. Шкірні покриви пацієнта набули сірого забарвлення, а губи - ціанотичного відтінку. Який невідкладний захід треба здійснити до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- А. Серцево-легеневу реанімацію
- В. Вдарити долонею між лопатками
- С. Оксигенотерапію
- D. Прийом Геймліха**
- Е. Конікотомію

113. У пацієнта віком 40 років, який перебуває на лікуванні в щелепно-лицевому стаціонарі з діагнозом: флегмона дна порожнини рота, спостерігається погіршення загального стану, підвищення температури до 40^oC. Лікар визначив позитивні симптоми Герке, Іванова, Равич-Щербо. Яке ускладнення, ймовірно, розвинулося у пацієнта?

- А. Токсемія
- В. Тромбофлебіт
- С. Сепсис
- D. Тромбоз
- Е. Медіастиніт**

114. Чоловік віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лівого слухового проходу та хрускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, пропорційне, рухи нижньої щелепи мають

девіацію та викликають біль. Під час внутрішньоротової пальпації відчувається напруженість латеральних крилоподібних м'язів. На комп'ютерній томографії структури суглобових поверхонь рівні та гладкі, патологічних змін не виявлено. Який імовірний діагноз?

- A. Дисфункція СНЩС
- B. Ревматичний артрит СНЩС
- C. Хронічний артрит СНЩС
- D. Анкілоз СНЩС
- E. Деформуючий артроз СНЩС

115. Чоловіка віком 45 років шпиталізовано до лікарні з місця ДТП з діагнозом: забійно-рвана рана щоки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. До яких травм належать ці пошкодження?

- A. Комбінованих
- B. Множинних
- C. Поодиноких
- D. Ізольованих
- E. Поєднаних

116. Підліток віком 15 років скаржиться на постійну кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі. Об'єктивно спостерігається: набряк, гіперемія та ціаноз ясен у фронтальній ділянці нижньої щелепи, ясенні сосочки набряклі та легко кровоточать під час зондування. Наявні над'ясенні щільні зубні нашарування. Вкажіть додатковий метод обстеження для встановлення остаточного діагнозу.

- A. Реопародонтографія
- B. Телерентгенографія
- C. Електроодонтодіагностика
- D. Стоматоскопія
- E. Рентгенографія

117. Чотирнадцятирічний хлопчик скаржиться на випадіння пломби та наявність порожнини у зубі нижньої щелепи зліва. Об'єктивно спостерігається: 36 зуб зруйнований на 1/2, порожнина зуба відкрита, на вустах корневих каналів залишки пломбувального матеріалу, термопроба негативна, зондування, перкусія безболісні. На рентгенограмі виявлено розширення періодонтальної щілини коренів 36 зуба. Установіть імовірний діагноз.

- A. Хронічний фіброзний періодонтит
- B. Хронічний гранулюючий періодонтит
- C. Хронічний гангренозний пульпіт
- D. Хронічний фіброзний пульпіт

E. Хронічний гранулематозний періодонтит

118. У шестирічної дитини на контактних та жувальних поверхнях 84, 85 та 75 зубів наявні каріозні порожнини темно-коричневого кольору в межах щільного плащового дентину. Препарування емалево-дентинної межі болісне. Який пломбувальний матеріал доцільно використати?

- A. Силікофосфатний цемент
- B. Склоіономерний цемент
- C. Цинк-фосфатний цемент
- D. Полікарбоксилатний цемент
- E. Силікатний цемент

119. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на постійний пульсуючий, іррадіюючий біль у зубі нижньої щелепи зліва, що посилюється під час накушування, відчуття 'вирослого' зуба. Біль виник три дні тому. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 36 зуба каріозна порожнина, що не сполучається з пульповою камерою зуба. Зондування та термодіагностика безболісні, перкусія різко болісна. Слизова оболонка перехідної складки у ділянці проєкції коренів 36 зуба набрякла, гіперемована, болюча під час пальпації. На рентгенограмі деструктивних змін кісткової тканини біля верхівок коренів 36 зуба не виявлено. Який імовірний діагноз?

- A. Гострий серозний періодонтит
- B. Загострення хронічного періодонтиту
- C. Гострий гнійний пульпіт
- D. Загострення хронічного пульпіту
- E. Гострий гнійний періодонтит

120. Під час обстеження лікарем-стоматологом у пацієнта віком 45 років виявлено зміну кольору 12 зуба. З анамнезу відомо, що зуб раніше був лікований з приводу ускладненого карієсу. Прикус прямий. В якості протезної конструкції лікар запропонував виготовлення металокерамічної коронки. На яку товщину треба відпрепарувати тверді тканини опорного зуба у цій клінічній ситуації?

- A. 0,3-0,5 мм
- B. 0,6-0,9 мм
- C. -
- D. 1,0-1,3 мм
- E. 1,5-1,8 мм

121. Чоловік віком 35 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення на нижній губі.

Об'єктивно на незмінній червоній облямівці нижньої губи зліва спостерігається напівкулястої форми вузол діаметром 0,6 см, щільної консистенції, підвищується над рівнем червоної облямівки, вкритий сірими лусочками. Пальпація безболісна. Який попередній діагноз?

- А. Кератоакантома
- В. Папілома
- С. Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи
- Д. **Бородавчастий передрак**
- Е. Піогенна гранульома

122. У чоловіка віком 52 роки на шкірі правої щоки спостерігається щільна, болюча, конічної форми ділянка запалення з гнійно-некротичним стрижнем всередині. Який імовірний діагноз?

- А. Бешиха
- В. Нома
- С. Сибірка
- Д. Карбункул
- Е. **Фурункул**

123. Чоловіку віком 25 років діагностовано перелом коренів на 1/3 довжини інтактних 41 і 42 зубів та показано їх видалення. Який метод лікування найдоцільніше застосувати пацієнту відразу після видалення зубів?

- А. Адгезивну конструкцію
- В. Відновлення знімним протезом
- С. Протезування імедіат-протезом
- Д. **Безпосередню імплантацію**
- Е. Виготовлення мостоподібного протезу

124. До лікаря-стоматолога звернулися батьки семирічної дівчинки для профілактичного огляду та контролю якості герметизації фісур у 16, 26, 36, 46 зубах, що була здійснена півроку тому. Герметик зберігся у 16 та 26 зубах. Яка подальша тактика лікаря?

- А. Покрити зуби фторлаком
- В. Провести профілактичне пломбування
- С. **Повторити герметизацію**
- Д. Призначити іонофорез із гліцерофосфатом кальцію
- Е. Призначити повторний огляд дитини за 6 місяців

125. У пацієнта віком 56 років під час огляду лікарем-стоматологом виявлено асиметрію обличчя через веретеноподібне стовщення тіла нижньої щелепи справа.

Шкіра над припухлістю береться у складку, регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, зуби нижньої щелепи у цій ділянці інтактні, перехідна складка згладжена, у кольорі не змінена. На рентгенограмі спостерігається вогнище деструкції кісткової тканини тіла нижньої щелепи, що має форму багатокамерної порожнини з чіткими краями. Який імовірний діагноз?

- А. Остеобластокластома
- В. Внутрішньокісткова фіброма
- С. Парадентальна кіста щелепи
- Д. **Амелобластома**
- Е. Хронічний остеомієліт

126. Пацієнт віком 46 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність кровоточивої виразки на нижній губі, що виникла близько двох місяців тому. Об'єктивно спостерігається: на слизовій оболонці нижньої губи праворуч виразка неправильної форми, з кратероподібними, вивернутими краями, до 1,0 см у діаметрі. Пальпаторно визначається щільний інфільтрат навколо виразки. Регіонарні лімфатичні вузли щільні, спаяні, безболісні. Установіть попередній діагноз.

- А. **Рак нижньої губи**
- В. Обмежений гіперкератоз
- С. Хейліт Манганотті
- Д. Хронічна тріщина нижньої губи
- Е. Декубітальна виразка нижньої губи

127. Батьки чотирирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у передньому зубі верхньої щелепи дитини, зміну його положення, неможливість відкушування їжі. Декілька годин тому хлопчик отримав травму обличчя. Об'єктивно спостерігається: конфігурація обличчя не змінена, на шкірі нижньої губи та підборідді садно, слизова оболонка нижньої губи травмована, 51 зуб рухомий I ступеня, невелике зміщення його положення вестибулярно у сагітальному напрямку. На рентгенограмі визначається рівномірне розширення періодонтальної щілини 51 зуба. Яка тактика лікаря після обробки рани?

- А. **Динамічне спостереження**
- В. Ендодонтичне лікування 51 зуба
- С. Реплантація 51 зуба
- Д. Видалення 51 зуба
- Е. Професійна гігієна порожнини рота

128. Чоловік віком 69 років скаржиться на прогресуючу асиметрію обличчя, парез м'язів обличчя. Під час огляду виявлено новоутворення у привушній ділянці справа попереду мочки вуха без чітких меж, до 7 см у діаметрі, спаяне з навколишніми тканинами. Який попередній діагноз?

- A. Ліпома
- B. Псевдопаротит Герценберга
- C. Змішана пухлина
- D. Атерома
- E. Аденокарцинома

129. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль у зубі, який з'явився через тиждень після лікування карієсу. Об'єктивно спостерігається: у 14 зубі композитна пломба, зуб сірого кольору, термодіагностика позитивна на гаряче, перкусія чутлива, пальпація у ділянці проєкції кореня 14 зуба безболісна. Якої помилки припустився лікар під час попереднього прийому пацієнта?

- A. Не проведено додаткові методи дослідження
- B. Недостатньо зроблена некректомія дентину
- C. Не використана кальцієвмісна паста
- D. Пломба не пришліфована по оклюзії
- E. Не проведено знеболювання

130. У чоловіка віком 42 роки під час огляду лікарем-стоматологом виявлено збільшення ниткоподібних сосочків язика зі зроговінням різного ступеня. Пацієнт скаржиться на присмак заліза у роті. Після ретельного обстеження встановлено діагноз: чорний волосатий язик. Які лікарські засоби доцільно застосувати у цьому разі?

- A. Протівірусні
- B. Вітаміни
- C. Антисептики
- D. Кератопластичні
- E. Кератолітичні

131. Під час лікування загострення хронічного періодонтиту 26 зуба пацієнтка віком 63 роки поскаржилася на головний біль, головокружіння, відчуття запаморочення та мерехтіння в очах. Об'єктивно спостерігається: гіперемія обличчя, холодний липкий піт, розширення зіниць, пульс прискорений, артеріальний тиск - 200/95 мм рт. ст. Який імовірний діагноз?

- A. Гостре порушення мозкового кровообігу
- B. Гіпертонічний криз
- C. Анафілактичний шок
- D. Колапс
- E. Інфаркт міокарда

132. У пацієнта віком 16 років на вестибулярній поверхні різців та перших молярів верхньої щелепи лікарем-стоматологом виявлено симетрично розташовані білі плями. Реакція на хімічні та температурні подразники відсутня, зондування безболісне, поверхня плям гладенька. Розчином 2%-го метиленового синього плями не забарвлюються. Який імовірний діагноз?

- A. Некроз емалі
- B. Ерозія твердих тканин зубів
- C. Системна гіпоплазія емалі
- D. Множинний карієс у стадії білої плями
- E. Місцева гіпоплазія емалі

133. Який симптом характерний для продромального періоду у пацієнтів, які хворіють на рецидивний лабіальний герпес?

- A. Свербіння
- B. Оніміння
- C. Гіпертермія
- D. Озноб
- E. Почервоніння

134. Чоловік віком 58 років скаржиться на гострі, подібні до удару електрострумом, напади болю у підочній ділянці верхньої щелепи справа під час вживання їжі, гоління, умивання. Біль супроводжується ринореєю, гіперсалівацією, слъозотечею. Який імовірний діагноз?

- A. Невралгія 2-ої гілки трійчастого нерва
- B. Невралгія 1-ої гілки трійчастого нерва
- C. Гангліоніт крило-піднебінного вузла
- D. Неврит лицевого нерва
- E. Неврит 2-ої гілки трійчастого нерва

135. У пацієнта віком 32 роки під час профілактичного огляду лікар-стоматолог на слизовій оболонці нижньої губи виявив багрянню пляму діаметром до 1,0 см, пласку, з чіткими межами, що під час натискання різко 'світлішає'. Який імовірний діагноз?

- A. Піогенна гранульома
- B. Гемангіома
- C. Кіста малої слинної залози
- D. Лімфангіома

Е. Судинна мальформація

136. Чоловік віком 38 років скаржиться на неприємні відчуття у порожнині рота. З анамнезу відомо, що пацієнт палить 20 років, має періодичні болі у животі. Об'єктивно спостерігається: СОПР бліда, на боковій поверхні язика наявні відбитки зубів, на спинці - наліт сірого кольору та вогнища десквамації. Встановлено діагноз: десквамативний глосит. До лікаря якої спеціалізації треба направити пацієнта на консультацію?

- А. Гастроентеролога
- В. Невропатолога
- С. Ендокринолога
- Д. Фтизіатра
- Е. Хірурга

137. Хлопець віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхнього зуба мудрості зліва, травми щоки під час жування. Об'єктивно спостерігається: 28 зуб прорізався в щічному напрямку та розташований поза зоною оклюзійних співвідношень. Показано видалення 28 зуба. Рентгенологічно виявлено тонкий рівень кісткової тканини навколо нього у вестибулярному напрямку. Яку методику найдоцільніше застосувати для попередження ускладнень під час видалення зуба?

- А. Використання елеваторів із товстими щічками
- В. Атравматичне видалення за допомогою п'єзотому
- С. Видалення багнетоподібними щипцями з люксаційними рухами
- Д. Використання періотому з пікоподібною насадкою
- Е. Застосування фізіодиспенсера для препарування кісткової тканини

138. Жінка віком 49 років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, що виникло місяць тому після гострого тонзиліту, підвищення температури тіла до 37,2°C. Проводилася протизапальна терапія. Об'єктивно спостерігається: у правій підщелепній ділянці кулясте новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, діаметром 2 см. Шкіра у кольорі не змінена. З протоки слинної залози виділяється прозора слина. Який імовірний діагноз?

- А. Хронічний лімфаденіт

- В. Аденома слинної залози
- С. Слинокам'яна хвороба
- Д. Атерома
- Е. Хронічний сіалоаденіт

139. Чоловік віком 32 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на утруднене відкривання рота та біль у ділянці кута нижньої щелепи. Для видалення 38 зуба через перикоронарит лікар вибрав знеболювання за методом Берше-Дубова. На яку глибину треба просунути голку для проведення анестезії цією методикою?

- А. 2-2,5 см
- В. 4-4,5 см
- С. 1-1,5 см
- Д. 3-3,5 см
- Е. -

140. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулася мати дівчинки віком 10 років зі скаргами на естетичний недолік у дитини. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, непропорційне через збільшення нижньої третини, рот напіввідкритий, губи у стані фізіологічного спокою не змикаються. Під час огляду порожнини рота виявлено: співвідношення перших постійних молярів нормогнатичне, між верхніми та нижніми центральними та латеральними різцями наявна вертикальна щілина 4 мм. Яка ортодонтична патологія у дитини?

- А. Дистальний прикус
- В. Глибокий прикус
- С. Звуження нижнього зубного ряду
- Д. Звуження верхнього зубного ряду
- Е. Відкритий прикус

141. У чоловіка віком 68 років на слизовій оболонці м'якого піднебіння виявлено пляму округлої форми, діаметром 1 см, поверхня її застійно-червоного кольору, бархатиста, з дрібними сосочковими виростами. Осередок трохи западає порівняно з навколишніми тканинами. Пальпація безболісна, ущільнення немає. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який основний метод лікування цієї патології?

- А. Фізіотерапевтичний
- В. Терапевтичний
- С. Хірургічний
- Д. Ортодонтичний
- Е. Ортопедичний

142. У пацієнта з діагнозом серцева недостатність II стадії виявлено болісну виразку у ретромолярній ділянці порожнини рота. Дно виразки вкрито фібринозним нальотом, запальний інфільтрат навколо виразки відсутній. Яка стоматологічна допомога доцільна у цьому разі?

- A. Місцеве знеболювання й репаранти**
- B. Хірургічне лікування**
- C. Місцево глюкокортикостероїди**
- D. Протигрибкове лікування**
- E. Антисептичні або антибактеріальні засоби**

143. У чоловіка віком 80 років спостерігаються множинні елементи ураження шкіри: висипи, нашарування, бляшки, зроговіння, ерозії, тощо. Яке новоутворення шкіри пацієнта може трансформуватись у меланому?

- A. Невус**
- B. Кератоакантома**
- C. Базаліома**
- D. Папілома**
- E. Гемангіома**

144. Під час стоматологічного огляду у чоловіка віком 28 років на бічній поверхні язика зліва виявлено овальну безболісну виразку, розміром до 1,0 см з рівними припіднятими краями та гладкою блискучою поверхнею. Пальпаторно визначається хрящоподібна інфільтрація дна виразки. Спостерігається односторонній склероденіт зліва. Встановіть попередній діагноз.

- A. Трофічна виразка**
- B. Ракова виразка**
- C. Туберкульозна виразка**
- D. Декубітальна виразка**
- E. Сифілітична виразка**

145. Жінка віком 40 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на інтенсивний, але нетривалий біль у ділянці нижніх центральних зубів від температурних, хімічних та механічних подразників. Біль виник після проведення професійної гігієни тиждень тому. Під час огляду спостерігається: зуби нижньої щелепи інтактні, корені нижніх різців оголені на 1/3 висоти, показники ЕОД зубів - 3 мкА. Якому діагнозу відповідають ці клінічні симптоми?

- A. Гострий пульпіт**
- B. Гострий поверхневий карієс**

- C. Ерозія зубів**
- D. Гіперемія пульпи зубів**
- E. Гіперестезія зубів**

146. Дев'ятирічний хлопчик скаржиться на косметичний дефект. Під час внутрішньоротового обстеження встановлено, що перші постійні моляри змикаються за I класом Енгля, а між верхніми центральними різцями ширина щілини становить 2 мм, коронки різців нахилені латерально. Встановлено діагноз: діастема на верхній щелепі. Який ортодонтичний апарат треба вибрати для лікування цієї патології?

- A. Брекет-система**
- B. Піднебінна пластинка з гвинтом для розширення верхнього зубного ряду**
- C. Апарат Андрезена-Гойпля**
- D. Апарат Осадчого**
- E. Піднебінна пластинка з рукоподібними кламерами**

147. Батьки чотирнадцятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на відсутність у дитини верхнього зуба справа. Під час клінічного огляду виявлено, що 13 зуб відсутній у зубному ряді. На КТ спостерігається: 13 зуб ретенований, розташований з піднебінної сторони. Після проведених досліджень встановлено, що ширина 13 зуба становить 7 мм, відстань між 12 та 14 зубами становить 5 мм. Яку тактику лікування доцільно вибрати у цьому клінічному випадку?

- A. Лікування брекет-системою у комбінації з хірургічним методом**
- B. Видалення ретенованого зуба у комбінації з протетичним методом**
- C. Лікування знімною ортодонтичною апаратурою**
- D. Протетичний метод лікування**
- E. Диспансерне спостереження до 16 років**

148. Під час профілактичного огляду лікарем-стоматологом восьмирічної дівчинки на слизовій оболонці альвеолярного відростка в ділянці 84 зуба виявлено норицю. Об'єктивно спостерігається: зуб заплomboваний, перкусія його безболісна. Рентгенологічно наявне вогнище просвітлення кісткової тканини у ділянці біфуркації 84 зуба з нечіткими контурами та резорбція дистального кореня на 2/3 його довжини. Виберіть доцільну лікувальну тактику.

- A. Імпрегнація кореневих каналів
- B. Ендодонтичне лікування кореневих каналів із постійною obturaцією
- C. Спостереження в динаміці до фізіологічної зміни зуба
- D. Ендодонтичне лікування кореневих каналів з тимчасовою obturaцією
- E. Видалення 84 зуба

149. Пацієнтці віком 42 роки показано видалення 17 зуба через загострення хронічного періодонтиту. Під час операції з видалення зуба піднебінний корінь потрапив у верхньощелепову пазуху. Яка тактика лікаря-стоматолога у цій клінічній ситуації?

- A. Провести операцію гайморотомії
- B. Затампонувати лунку йодоформною турундою
- C. Провести рентгенологічне обстеження і направити пацієнтку до стаціонару
- D. Ушити комірку видаленого зуба
- E. Видалити корінь через перфораційний отвір, що утворився

150. У вагітної жінки віком 28 років під час стоматологічного огляду на яснах у ділянці штучної коронки 27 зуба виявлено пухлиноподібне утворення розміром 1x1 см на широкій основі округлої форми, вкрите ціанотичною слизовою оболонкою, кровоточить від дотику інструментом. Який імовірний діагноз?

- A. Одонтома
- B. Епуліс
- C. Рак слизової оболонки
- D. Гемангіома
- E. Пухлина слинної залози